

PRINCIPIOS GENERALES

Ley 100 de 1993

DEFINICIÓN DE ESTOS



EFICIENCIA:

Es la regla que exige utilizar de la mejor forma los recursos económicos, administrativos y técnicos del sistema. Garantizar que los beneficios de la seguridad social se entreguen de forma adecuada, oportuna y suficiente.



PARTICIPACIÓN

Las personas pueden opinar, hacer propuestas, presentar quejas y supervisar los servicios para asegurar que la atención sea de calidad y responda a las necesidades de la comunidad.



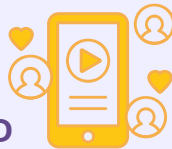
UNIDAD

Es la articulación y trabajo conjunto de instituciones, políticas y trámites para ofrecer una atención en salud continua, organizada y de calidad



INTEGRALIDAD

Es la protección total del paciente. La atención no solo cura enfermedades, sino que incluye prevención, diagnóstico y cuidados continuos de calidad para garantizar su bienestar general, sin interrupciones y cubriendo todas sus necesidades.



UNIVERSALIDAD

El derecho de todo ser humano, sin importar su nacionalidad, etnia, género, religión o condición social, a tener acceso a los mismos derechos. Esto significa que las leyes deben proteger y garantizar el bienestar de todas las personas por igual.

SOLIDARIDAD

Práctica de ayuda mutua entre personas, generaciones, sectores económicos, regiones y comunidades, bajo el principio de que el más fuerte ayuda al más débil.



ENTIDADES

- **EPS:** ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
- **IPS:** INSTRUCCIÓN PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD.
- **ARL:** ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES.
- **AFP:** ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PRESTACIONES



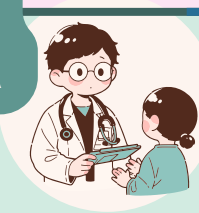
RÉGIMEN SUBSIDIADO.

Están las personas que no tienen capacidad de pago, y las más vulnerables.

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO.

Todas las personas tienen la obligación de cotizar el 4% del salario mínimo legal y el empleador el 8.5%.

BARRERAS DEL SISTEMA DE SALUD EN COLOMBIA



1. FALLAS EN LA ATENCIÓN MÉDICA Y CITAS:

Tiempos de espera muy extensos para la asignación de citas, especialmente con médicos especialistas. Escasez y saturación: Falta de personal de salud y sobrecarga en la capacidad de los servicios de atención.

2. TRÁMITES Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

- Trámites excesivos: Procesos burocráticos que retrasan la atención.
- Autorizaciones y suministros: Demoras en aprobar procedimientos y entregar medicamentos.
- Falta de coordinación: Escasa comunicación entre EPS e IPS que afecta la continuidad del servicio.

3. ACCESO, COBERTURA Y DESIGUALDAD

- Acceso a los servicios: Las brechas geográficas, económicas y la congestión en los puntos de atención dificultan el acceso oportuno a los servicios de salud.

¿CÓMO APORTAMOS DESDE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN SALUD?

EFICIENCIA



- Agilizando los trámites y optimizando los tiempos de atención para brindar un servicio oportuno y de calidad.

UNIVERSALIDAD



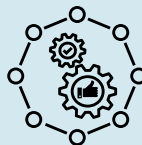
- Orientando a los usuarios sobre sus derechos y facilitando el acceso a los servicios de salud sin barreras.

SOLIDARIDAD



Priorizando la atención y el acompañamiento de las personas en condición de mayor vulnerabilidad

INTEGRALIDAD



- Coordinando los procesos para garantizar la continuidad de la atención y los tratamientos.

UNIDAD



- Fortaleciendo la comunicación y la coordinación entre las diferentes entidades del sistema de salud

PARTICIPACIÓN



Escuchando al usuario, promoviendo el uso de las PQRSF y fomentando su participación en el mejoramiento del servicio